

sistema

NS			
MARIA ELZA DOS SANTOS			
IDADE: 77a	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS: sonolência / edema / MMII / Dor de cabeça.			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Atacandi / Anodipina			
Ac			
MÉDICO: Dr. Mario Jorge - Dr. Eduardo Vasconcelos.			
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 9hrs		HORA QUE ACORDA: 5hrs	
COCHILO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO:			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 35cm	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH: 29.6	SPO2: 90%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:		PSG-29.6 / P=10cmH2O	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA		Teve herpes Zoster	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não → nódulo tireoide			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS.			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Sinusite			
27/06/23 P=10cmH2O			
10/07/23 P=10cmH2O Bem adaptado			
IAH=2.3			
M. de uso: 6h30'			
07/08/23 P=40cmH2O			
IAH=14.2/h			
M. de uso: 6h45'			
fuga=48l/min mediana 7.8l/min			
06/09/23 P=10cmH2O mto escape. / ajuste máscara			
IAH=4.72/h			
M. de uso: 6h20'			
fuga=39.7l/min mediana 7.5l/min			
04/10/23 P=10cmH2O mto usando faixa no queixo p/ escape			
IAH=1.82/h			
fuga=33			
M. de uso: 6h16'			
13/11 P=10cmH2O			
23 IAH=1.52/h			
M. de uso: 5h34'			
fuga=33.6l/min			
Relata que apresentou uma prova velozmente uma convulsão, oriento consul			

06/12/23 P=10cmH₂O
IAH=2,3 e/h
m. uso= 6h54'
fuga= 40 l/min
moder. língua à noite
↳ com refluxo?
pneu Neuro
foco fixo

10/01/24 P=10cmH₂O
IAH=1,6 e/h
m. uso= 5h50 min
fuga= 44 l/min
exame Neuro= OK s/ alterações.
filata bem disposta.

11/03/24 P=10,0cmH₂O
IAH=1 e/h
m. de uso 7hs
tosta bem adaptada
tato, exueto OK

12/11/24 Troco filtro

13/05/25 P=10cmH₂O
IAH=2,0 e/h
m. de uso: 8hr
troco fixador
Painho
filtro
fuo

20/10/25 P=10cmH₂O
IAH=1,0
muro: 7h42
fuga= 36 l/min
morde língua / usa placa buxismo
- bre encefalite out/2024 - internar
- foco fixo Silvin

21/01/2026 web Doctor. OK

Nome: MARIA ELZA DOS SANTOS

Data de Nascimento: 5-11-1945

IMC: 35,56

Sexo: Feminino

Data do exame: 26-04-2023

Peso: 80 kg

Altura: 1,50 m

Médico: DR. MARIÓ SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 26-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 534,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 37,0 e 87,5 minutos. O tempo total de sono foi de 471,0 min, eficiência de 88,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 60,6%; estágio N3: 13,6%; sono REM: 23,7%. O índice de despertares foi de 17,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 29,6/hora, sendo 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 228 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 85%, permanecendo 1,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 44 - 85 bpm e NREM de 45 - 83 bpm.

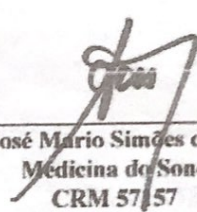
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 10,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57